

자궁경부암 진단 첫 30일

병기 · 수술 · 항암방사선치료 핵심 정리

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 12

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

“HPV 양성”과 “침윤성 자궁경부암 확진”은 같은 말이 아닙니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Cervical Cancer, Version 2.2026 외 국내 자료 (본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

지금 내 상황	먼저 펼 곳
방금 진단을 들었고 머리가 하얗다	1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」
몸에 이상 신호가 있다	「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)
다음 주에 진료가 잡혀 있다	해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」
검사 결과지를 받았다	PART 1의 병리·검사·병기 장
돈·보험·회사가 걱정이다	PART 5 「돈 · 서류 · 제도」
마음이 무너질 것 같다	PART 4 「마음 돌보기」
가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다	PART 4 「보호자에게」

각 장의 구성은 같습니다.

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **🆘 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 전암병변과 침윤암

30초 요약

- **HPV 양성 ≠ 암.** 비정상 세포검사나 HPV 양성은 "더 확인이 필요하다"는 뜻입니다.
- **전암병변(CIN·AIS) ≠ 침윤암.** 치료 범위가 완전히 다릅니다.
- 침윤암은 **조직검사로 확진**하고, 종양 크기·주변 침범·림프절·원격전이를 보고 **FIGO 병기**를 정합니다.
- 임신을 원한다면 **치료를 정하기 전에** 말해야 합니다.

결과지에 적힌 말	뜻	이 책에서 볼 곳
HPV 양성, ASC-US, LSIL	세포 변화나 바이러스 감염. 암 확진이 아님	6장
CIN2·CIN3, HSIL, AIS(상피내선암)	전암병변. 원추절제 등으로 치료	1장 아래 상자
미세침윤암(IA)	현미경으로만 보이는 아주 초기 침윤암	5·8·9장
침윤성 편평상피암·선암·선편평상피암	자궁경부암 확진	이 책 전체
신경내분비암(소세포암 등)	드물고 치료 경로가 다름	14장

전암병변(CIN3·AIS)이라고 들었다면: 이 책의 많은 내용(병기·항암방사선)은 해당하지 않습니다. 원추절제 결과와 추적검사 일정을 담당 의사와 확인하세요. 다만 원추절제 후 "미세침윤"이 발견되면 이 책 5장부터 다시 보시면 됩니다. **근종 등으로 자궁을 뚫 뒀 침윤암이 나왔다면:** 남은 자궁주위조직·질 상부·골반 림프절을 더 떼는 수술이나 항암방사선을 검토합니다. 첫 수술 병원의 병리 슬라이드·수술기록지를 챙겨 부인종양 전문의에게 가세요.

자궁경부암의 조직형

- **편평상피암:** 가장 흔합니다. 자궁경부 바깥쪽(질 쪽)에서 주로 시작합니다.
- **선암:** 두 번째로 흔하며 자궁경부 안쪽(자궁 쪽)에서 시작합니다. 세포검사로 찾기 더 어려울 수 있습니다.
- **선편평상피암:** 두 가지가 섞인 형태.
- **신경내분비암(특히 소세포암):** 드물고 빨리 자랄 수 있어 별도 치료 경로를 따릅니다(14장).

첫 30일의 지도

순서	할 일	대략 시기
①	조직 확진 · 조직형 확인	Day 0-3
②	골반 MRI(국소) + PET/CT(원격) 등 병기 검사	Day 3-14
③	가임력 희망 여부를 의료진에게 알리기	첫 진료
④	수술 경로 vs 항암방사선 경로 결정	Day 10-21
⑤	치료 준비(난자 동결·난소전위·근접치료 병원 확보 등)	Day 14-30
⑥	진행·재발이면 PD-L1 등 바이오마커와 전신치료 계획	경우에 따라

오늘 물어볼 질문

1. 제 결과는 전암병변인가요, 침윤성 자궁경부암인가요?
2. 조직형은 무엇이고, 지금 예상하는 병기는 어디쯤인가요?
3. 최종 치료를 정하기 전에 어떤 검사가 더 필요한가요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자 — 아래 증상은 다음 예약까지 기다리지 말고 바로 연락하거나 응급실로

- 패드가 1시간 안에 흠뻑 젖을 정도의 **질 출혈**, 어지럼·실신·가슴 두근거림
- **38°C 이상 발열**(특히 항암치료 중), 오한, 악취 나는 분비물과 심한 골반통
- **한쪽 다리가 갑자기 붓고 아픔**, 갑작스러운 흉통·숨참(혈전·폐색전 가능성)
- **소변이 거의 나오지 않음**, 심한 옆구리 통증(요관 막힘 가능성)
- 하루 6회 이상 설사나 반복 구토로 **물을 마실 수 없음**
- 새로 생긴 다리 힘 빠짐·감각 저하, 대소변 조절 이상, 심한 허리 통증
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

같은 내용을 본문 목록으로 한 번 더 적습니다. 보호자도 읽어 두세요.

1. 많은 질 출혈 + 어지럼 → 빈혈·급성 출혈 평가가 필요합니다.
2. 발열 + 오한 + 악취 분비물 + 골반통 → 감염 가능성이 있습니다.
3. 한쪽 다리 부종·통증, 흉통·호흡곤란 → 정맥혈전·폐색전 가능성이 있습니다.
4. 소변량 급감, 옆구리 통증 → 종양이 요관을 눌러 신장 기능이 떨어질 수 있습니다.
5. 치료 중 38°C 이상 발열, 탈수 → 혈구 감소나 감염 가능성이 있습니다.
6. 새 신경 증상 → 척추·신경 압박 가능성이 있습니다.

첫 치료 전에 할 일: 평일 진료실, 야간·휴일 연락처, 가까운 응급실을 내 휴대폰과 보호자 휴대폰에 저장하세요(워크북 W1 「비상 연락처 카드」). 치료 중 응급 기준은 치료 병원 안내가 우선입니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 세 가지만 하세요. ① 병리보고서 받기 ② 부인종양 전문의 진료 예약 ③ 임신 희망 여부 정리. 나머지는 이번 주에 해도 됩니다.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 병리보고서(조직검사 결과지) 사본 받기 — "침윤성 암"인지, 조직형이 무엇인지 확인
- ☐ **부인종양 전문의** 진료 예약 — 산부인과 중에서도 부인암 수술·치료를 전문으로 하는 의사
- ☐ 앞으로 임신을 원하는지 생각해 두기 — "모르겠다"도 괜찮습니다. 그 자체를 첫 진료에서 말하세요.

이번 주 할 일

- ☐ 어떤 방법으로 진단됐는지 확인(핀치 생검 / 원추절제(LEEP·냉원추절제))
- ☐ 병기 검사 일정 확인: 골반 MRI, PET/CT(또는 흉부·복부·골반 CT), 혈액검사
- ☐ 의료진이 권하면 **HIV 검사** — 국제 지침이 진단 시 권장하는 기본 검사입니다. HIV가 있어도 치료 선택지는 같으며, 양성이면 HIV 전문의와 함께 진료합니다.
- ☐ 다른 병원으로 옮기거나 2차 소견을 원하면 병리 슬라이드·블록, 영상 CD 대여 방법 확인
- ☐ **산정특례 신청** 여부를 원무과에 확인(확진일로부터 30일 이내 신청 시 확진일부터 적용, 공단 확인 필요)
- ☐ 흡연 중이라면 금연 지원 요청 — 치료 효과와 회복에 영향을 줍니다
- ☐ 현재 출혈량, 골반통, 소변·대변 변화, 체중·식사량 메모

보호자 몫

- □ 진료에 동행해 답을 받아 적기
- □ 연락처·일정 정리
- □ 환자에게 원인을 묻지 않기 — 특히 HPV에 대해서는 6장을 먼저 함께 읽어주세요

마음 점검 한 줄

지금 마음의 고통이 0~10 중 몇 점인지 적어 보세요: ____점. **4점 이상**이면 첫 진료에서 그대로 말하면 됩니다. 국제 지침은 진단 시점부터 마음 상태를 확인하도록 권합니다.

오늘 물어볼 질문

1. 제 진단은 침윤성 자궁경부암이 맞나요? 조직형은 무엇인가요?
2. 병기를 정하려면 어떤 검사를 언제 받나요?
3. 임신을 원한다면 치료 전에 무엇을 상의해야 하나요?

4장. 병리보고서 읽기

30초 요약: 병리보고서에서 먼저 볼 것은 **침윤암 여부 · 조직형 · 종양 크기 · 침윤 깊이 · LVSI · 절제면** 다섯 가지입니다.

항목	보고서 표현 예	왜 중요할까
침윤 여부	invasive / microinvasive / CIN3, AIS	전암과 암을 가르는 첫 기준
조직형	squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, adenosquamous, neuroendocrine	치료 경로, 가임력 보존·난소전위 가능성

항목	보고서 표현 예	왜 중요할까
침윤 깊이	depth of invasion 2.5 mm	IA1(3mm 미만) / IA2(3mm 이상 5mm 미만) 구분 — FIGO 2018은 가로 범위를 병기에 쓰지 않음
LVS(림프혈관 침범)	LVS present / absent	림프절 전이 위험 → 림프절 평가, 수술 범위, 가임력 보존
절제면	margin positive / negative	원추절제 후 추가 절제·수술 필요성

가상 보고서 한 줄씩 읽기 (예시, 실제 환자 아님)

`` [진단] Uterine cervix, LEEP: Invasive squamous cell carcinoma, moderately differentiated

- Depth of invasion: 4 mm, horizontal extent: 6 mm
- Lymphovascular space invasion: present
- Resection margins: endocervical margin involved by carcinoma ``

줄	쉬운 말	다음에 물어볼 것
Invasive squamous cell carcinoma	침윤성 편평상피암 — 자궁경부암 확진	"제 병기는 어떻게 예상되나요?"
moderately differentiated	중간 정도 분화(등급). 치료 결정에 주된 기준은 아님	—
Depth of invasion 4 mm	침윤 깊이 4mm → 미세침윤 중 IA2 범위 (최종 병기는 영상·추가 병리와 함께 결정)	"IA2라면 어떤 수술이 필요한가요?"
LVS present	림프혈관 침범 있음 → 림프절 평가가 필요할 가능성	"림프절 평가는 어떤 방법으로 하나요?"

줄	쉬운 말	다음에 물어볼 것
endocervical margin involved	자궁 쪽 절제면에 암이 남음 → 추가 원추절제나 수술 필요	"절제면 양성이면 다음 단계는?"

수술 후 최종 병리에서 추가로 보는 것

- 림프절 전이(몇 개 중 몇 개), 자궁주위조직(parametrium) 침범, 절제면 — 이 셋 중 하나라도 양성이면 수술 후 항암방사선을 고려하는 "고위험 인자"입니다 (10장).
- 종양 크기, 기질 침윤 깊이(얕음/중간/깊음), LVSI — 여러 개가 겹치면 수술 후 방사선을 고려하는 "중간위험 인자"입니다.

병리보고서 기록

조직 형	침윤암	종양 크기· 깊이	LVSI	절제 면	신경내분비 특성
	☐ 예 ☐ 아니오		☐ 없음 ☐ 있음		☐ 없음 ☐ 있음 ☐ ?

5장. 검사와 FIGO 병기

30초 요약

- 국소 평가는 골반 MRI, 몸 전체(림프절·원격전이) 평가는 PET/CT가 우선 권고입니다. PET/CT가 어려우면 흉부·복부·골반 CT, MRI가 어려우면 질식 초음파를 씁니다.
- 병기 숫자보다 "어디까지 퍼졌는지"를 이해하는 것이 중요합니다.
- 영상에서 림프절이 커 보이는 것과 실제 전이는 같은 말이 아닙니다.

검사	무엇을 보나	메모
골반 MRI	종양 크기, 질·자궁주위조직·방광·직장 침범	방사선 없음, 조영제 사용
PET/CT	골반·대동맥주위 림프절, 폐·간·뼈 전이	목~허벅지 촬영. 급여 기준 확인
흉부·복부·골반 CT	PET/CT를 못 할 때 원격 평가	
혈액검사	혈구, 신장·간 기능	요관 막힘이 있으면 신장 수치 상승
방광경·직장경	방광·직장 침범 의심 시	필요할 때만

FIGO 2018 병기 한눈에 보기

병기	쉬운 뜻	치료 흐름의 예(개인마다 다름)
IA1	침윤 깊이 3mm 미만	원추절제 또는 단순 자궁절제, 가임력 보존 가능
IA2	3mm 이상 5mm 미만	원추절제/자궁절제 + 골반 림프절 평가
IB1	침윤 5mm 이상, 2cm 미만	수술(위험도에 따라 단순~근치), 선별적 가임력 보존
IB2	2~4cm 미만, 자궁경부에 국한	근치 자궁절제 또는 항암방사선
IB3	4cm 이상, 자궁경부에 국한	수술 또는 항암방사선 + 근접치료
IIA1 / IIA2	질 상부 2/3 침범(4cm 미만 / 4cm 이상)	IIA1 수술 가능, IIA2 수술 또는 항암방사선
IIB	자궁주위조직 침범	항암방사선 + 근접치료

병기	쉬운 뜻	치료 흐름의 예(개인마다 다름)
IIIA / IIIB	질 하부 1/3 / 골반벽 또는 수신증	항암방사선 + 근접치료
IIIC1 / IIIC2	골반 / 대동맥주위 림프절 전이	항암방사선 + 근접치료(대동맥주위면 조사 범위 확장)
IVA	방광·직장 점막 침범	근치 목적 항암방사선 고려
IVB	원격전이(폐·간·뼈·면 림프절 등)	전신치료 중심 ± 국소치료(13장)

같은 "1기"라도 종양 크기, LVSI, 림프절 위험, 가임력 희망에 따라 치료가 달라집니다. 병기 숫자만으로 수술 여부를 결정하지 않습니다. 수술 뒤에 병기가 바뀌는 일(예: IB1 → IIIC1)은 "오진"이 아니라 **수술로 더 많은 정보가 생긴 결과**인 경우가 많습니다.

영상 판독지 단어장

판독지 표현	쉬운 말
parametrial invasion	자궁 옆 지지조직(자궁주위조직) 침범 → IIB 이상
hydronephrosis / hydroureter	수신증·요관 확장 — 소변길이 눌러 신장이 부음 → IIIB
lymphadenopathy, enlarged node	림프절이 커 보임 — 염증일 수도, 전이일 수도 있음
FDG uptake, SUVmax	PET에서 당 섭취가 높음 — 암세포 활동 가능성. 염증도 높게 보일 수 있음
para-aortic	대동맥 주위(복부) 림프절 → IIIC2
bladder/rectal mucosa involvement	방광·직장 점막 침범 → IVA(확인에 내시경 필요)

수술로 림프절을 먼저 확인하기도 합니다

국소진행성에서 대동맥주위 림프절 전이 여부가 방사선 범위를 바꿀 수 있을 때, 치료 전에 **복강경으로 림프절만 떼어 검사(수술적 병기 결정)**하는 병원도 있습니다. 모든 환자에게 필요한 것은 아니며, 병원 방침과 영상 결과에 따라 다릅니다.

검사 체크: 골반 MRI ☐ · PET/CT ☐ · CT ☐ · 혈액(신장 기능) ☐ · 방광경/직장경 ☐ · 림프절 평가 방법 __

오늘 물어볼 질문

1. 제 FIGO 병기는 무엇이고, 영상과 병리 중 무엇을 근거로 정했나요?
2. 림프절 전이는 확실한가요, 의심 단계인가요?
3. 이 병기에서 수술과 항암방사선 중 어느 쪽을 권하시나요?

6장. HPV 바로 알기 — 원인이지만 탓할 일은 아닙니다

30초 요약

- 고위험 HPV의 지속감염은 자궁경부암의 주요 원인입니다. 그러나 **HPV는 성생활을 하는 사람 대부분이 일생에 한 번쯤 노출되는 흔한 바이러스**입니다.
- 암 진단은 **당신의 잘못이나 행실의 결과가 아닙니다.**
- HPV 검사로 "누가 언제 옮겼는지" 알 수 없습니다. 바이러스는 수년간 잠복할 수 있습니다.

- 대부분은 면역이 스스로 HPV를 없애지만, 일부에서 오랜 기간 남아 세포를 바꿉니다. 이 과정은 보통 수년에서 수십 년이 걸립니다.
- 진단 후에는 HPV 유형보다 **병리와 병기**가 치료 결정에 직접 쓰입니다.
- 백신은 이미 생긴 암을 치료하지 않지만, 가족(자녀)의 예방에는 의미가 있습니다. 백신을 맞았어도 모든 고위험 유형을 막는 것은 아니어서 검진은 계속 필요합니다.

- 치료 후 추적에서 세포검사·HPV 검사를 어떻게 쓸지는 치료 종류(수술/방사선)에 따라 다릅니다.

자주 듣는 오해와 사실: "HPV 양성이니 반드시 암이다" · "HPV 음성이면 자궁경부암이 아니다" · "백신을 맞았으니 검진이 필요 없다" · "파트너가 바람을 피웠다는 증거다" — 모두 사실이 아닙니다.

파트너에게 이렇게 말해 볼 수 있습니다

"HPV는 아주 흔한 바이러스고, 언제 누구에게서 왔는지는 검사로 알 수 없대. 지금은 원인을 따지기보다 치료를 같이 준비하고 싶어."

파트너가 검사를 받아야 하는지, 성생활을 언제 다시 해도 되는지는 치료 단계에 따라 다르므로 담당 의료진에게 함께 물어보세요.

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

7장. 치료 경로 지도

30초 요약: 자궁경부암 치료는 크게 세 갈래입니다. ① **수술 중심(초기)** · ② **항암방사선 + 근접치료(국소진행)** · ③ **전신치료 중심(원격전이)**. 경계에 있는 병기(IB3·IIA2)는 두 길이 모두 가능해 상의가 필요합니다.

경로	주로 해당	핵심 치료	기간 감각
① 수술	IA-IB2, IIA1 (일부 IB3·IIA2)	원추절제 / 자궁경부절제 / 자궁절제(A·B·C1형) + 림프절 평가	수술 + 회복 2~6주, 최종 병리 후 추가치료 결정
② 항암방 사선	IB3·IIA2(선택) , IIB-IVA	외부방사선 5~6주 + 주 1회 항암 → 근접치료, 전체 7~8주 내 완료	약 2개월 매일 통원
③ 전신치 료	IVB, 원격 재발	항암 + (조건에 따라) 면역치료 ± 혈관신생억제제, 국소치료 병행	수개월 단위, 반응 평가하며 조정

치료를 "겹치지 않게" 설계합니다. 수술 후 방사선까지 받게 되면 부작용이 늘 수 있습니다. 그래서 수술 전 영상에서 림프절 전이가 의심되거나 종양이 크면 처음부터 항암방사선을 선택하기도 합니다.

시나리오로 보는 결정 과정 (가상 사례)

시나리오 A — IB1, 2cm 미만, LVSI 없음, 임신 희망 가임력 보존 조건(크기·조직형·LVSI·림프절)을 충족하는지 확인 → 원추절제 + 골반 림프절 평가 또는 근치적 자궁경부절제 → 생식의학과 동시 상담.

시나리오 B — IB2, 3cm, 출산 계획 없음 C1형 근치 자궁절제 + 림프절 평가가 일반적 선택. 수술이 어렵다면 외부방사선 + 근접치료(± 항암). 수술 후 최종 병리에 따라 추가치료.

시나리오 C — IIB, 골반 림프절 의심 항암방사선 + 근접치료가 표준. 병기에 따라 면역치료 병용, 또는 항암방사선 전 짧은 유도항암이 논의될 수 있음(국내 허가·급여 확인 필요). 근접치료 가능한 병원을 먼저 확보.

시나리오 D — IVB(폐 전이) 바이오마커(PD-L1 등) 확인 → 1차 전신치료 → 출혈·통증 같은 국소 증상에는 방사선 등 국소치료 병행. 완화의료를 처음부터 함께.

오늘 물어볼 질문

1. 제 병기에서 원하는 경로는 무엇이고, 다른 선택지는 무엇인가요?
2. 수술을 하면 수술 후 방사선이 추가될 가능성은 어느 정도인가요?
3. 결정까지 시간은 얼마나 있나요?

8장. 임신을 원한다면: 치료 전에 말하세요

30초 요약

- 아주 초기의 선별된 경우에는 **원추절제** 또는 **근치적 자궁경부절제**로 자궁을 보존할 수 있습니다.
- 방사선치료는 난소와 자궁에 영향을 줍니다. 가능성이 있다면 **치료 전에** 난자·배아 동결, 난소전위술을 상의합니다.
- 가임력 상담은 대개 **치료 일정 안에서 조율**할 수 있습니다. 걱정되면 "얼마까지 기다려도 안전한가요?"라고 직접 물어보세요.

병기별 가임력 보존 선택지 (조건을 모두 충족할 때, 담당 의료진 확인 필요)

병기	가임력 보존 방법
IA1	원추절제(LVSI가 있으면 림프절 평가 추가)
IA2	원추절제 + 골반 림프절 평가
IB1 저위험(LVSI 없음 등)	원추절제 + 골반 림프절 평가
IB1 그 외	근치적 자궁경부절제 + 림프절 평가
IB2	드물게 시행. 경험 많은 센터에서 신중히
IB3 이상	일반적으로 대상 아님

- 소세포 신경내분비암 등 일부 조직형은 가임력 보존 수술 대상이 아닙니다.
- 보존 수술 후 임신은 조산 위험이 있는 **고위험 임신**으로 관리합니다.
- **임신 중에 진단됐다면**: 조직검사는 임신 중에도 안전하게 할 수 있습니다.
 병기와 임신 주수에 따라 바로 치료할지, 아기가 태어날 수 있는 시기까지 미룰지를 산과와 부인종양팀이 함께 정합니다.
- **난소전위술**: 방사선 범위 밖으로 난소를 옮겨 난소 기능을 지키는 수술로, 폐경 전·폐경상피암에서 주로 고려합니다. 자궁이 받는 방사선의 영향(임신 능력)까지 막지는 못합니다.

자궁 보존 가능성 체크표

확인 항목	내 결과
종양 크기	_____ cm (2cm 미만인가?)
조직형	편평상피 / 선암 / 기타 _____
LVSI	없음 / 있음 / ?

확인 항목	내 결과
림프절	음성 / 의심 / ?
MRI상 남은 자궁경부 길이·내자궁경부 침범	----
생식의학과 상담	☐ 예약 ☐ 완료

남자·배아 동결 실무

- 과배란 주사부터 채취까지 보통 **2주 안팎**이 걸립니다. 생리 주기와 상관없이 시작하는 방법도 있어 치료 지연을 줄일 수 있습니다(기관 확인).
- **배아 동결**은 배우자(파트너)의 동의가 필요합니다. 미혼이거나 파트너가 없다면 **남자 동결**을 선택할 수 있습니다.
- 비용 지원은 지자체·제도에 따라 다르므로 생식의학과와 보건소에 확인하세요 (확인 필요).

2주 타임라인 예시

날짜	부인종양팀	생식의학팀
Day 1-3	진단·병기 검사 예약, 가임력 희망 전달	의뢰서 발급 → 상담 예약
Day 4-7	MRI·PET/CT	초음파·호르몬 검사, 방법 결정
Day 8-14	치료 방법 확정, 일정 공유	과배란·채취 → 동결
Day 14~	수술 또는 방사선 시작	결과 보고

오늘 물어볼 질문

1. 제 병기와 조직형에서 자궁 보존이 안전하게 가능한가요?
2. 방사선 가능성이 있다면 남자·배아 동결이나 난소전위를 지금 상의해야 하나요?
3. 가임력 보존 준비로 치료를 얼마나 미뤄도 괜찮나요?

9장. 초기 자궁경부암 수술

30초 요약

- 수술 범위는 **원추절제 → 단순(A형) 자궁절제 → 근치(B·C1형) 자궁절제** 순으로 넓어집니다.
- 저위험 기준(LVSI 없음 등)을 충족하는 IA2·IB1은 **단순(A형) 자궁절제 + 림프절 평가**가 가능하다는 것이 최근 권고입니다.
- 그 밖의 IA2·IB1, IB2·IIA1은 **C1형 근치 자궁절제 + 림프절 평가**가 일반적입니다.

수술	무엇을 떼어내나	주로
원추절제(LEEP·냉원추절제)	자궁경부의 원뿔 모양 조직	진단, IA1, 가임력 보존
근치적 자궁경부절제	자궁경부 + 질 상부 일부, 자궁·난소는 남김	가임력 보존 IB1
A형(단순) 자궁절제	자궁(자궁경부 포함)만	IA1, 저위험 IA2·IB1
B형 근치 자궁절제	자궁 + 주변 지지조직 일부 + 질 상부 소량	선택된 경우
C1형 근치 자궁절제	자궁 + 지지조직 상당 부분 + 질 상부 1/4~1/3	IA2·IB1(저위험 외), IB2, IIA1, (IB3·IIA2 수술 시)

림프절 평가

- 골반 림프절 절제 또는 **감시림프절 생검**(암이 처음 퍼지는 림프절만 찾아 떼어냄)을 합니다. 필요하면 대동맥주위 림프절도 확인합니다.
- 림프절을 많이 떼면 다리 림프부종 위험이 생길 수 있습니다(PART 4).

수술 방법: 개복 vs 복강경·로봇

근치 자궁절제는 **개복 수술이 표준으로 권고**되며, 최소침습(복강경·로봇) 근치 자궁절제는 연구에서 재발 위험 증가가 보고되었습니다. 단순 자궁절제나 림프절 수술은 최소침습으로 하기도 합니다. 제안받은 수술 방법과 그 이유를 꼭 물어보세요. 근치 수술 뒤 배뇨·배변 장애를 줄이려고 **신경을 보존하는 근치 자궁절제**를 하는 병원도 있으니, 내게 해당되는지 물어볼 수 있습니다.

난소는 보존하나요?

폐경 전이라면 난소를 남길 수 있는지 상의합니다. 난소를 떼면 즉시 폐경 증상(수술적 폐경)이 생기고, 장기적으로 뼈·심혈관 건강에 영향을 줄 수 있습니다. 선암은 난소 전이 가능성 때문에 판단이 다를 수 있습니다.

수술 전 2주 준비

- 복용 약 정리(혈액을 묽게 하는 약·당뇨약·건강기능식품) — 중단 시점은 의뢰진 지시
- 금연, 하루 20~30분 걷기로 체력 유지
- 입원 기간(보통 근치 수술은 수일~1주 안팎, 병원마다 다름)과 간병 계획
- 회사 제출 서류, 산정특례 등록 확인

회복 타임라인(일반적 예시)

시기	몸의 변화	할 일
수술 후 1-3일	통증, 소변줄	진통제 충분히, 조기 보행
1-2주	배뇨 감각 둔함(근치 수술 후 흔함), 피로	잔뇨 측정·자가도뇨 교육을 받을 수 있음
2-6주	점차 회복	무거운 물건·성관계·입욕 시점은 의뢰진 지시

시기	몸의 변화	할 일
최종 병리(1-2주)	—	추가치료 여부 결정(10장)

퇴원 후 38°C 이상 발열, 상처 발적·고름, 소변을 전혀 못 봄, 한쪽 다리 부종은 바로 연락합니다.

수술 전 기록: 수술명 __ · 수술 방법(개복/복강경/로봇) _ · 난소 보존 · 림프절 평가 방법 · 수술 후 방사선 가능성 ____

오늘 물어볼 질문

1. 제 경우 어떤 형태의 자궁절제(또는 보존 수술)를 권하시고, 그 이유는 무엇인가요?
2. 수술 방법(개복/최소침습)은 무엇이며, 재발 위험과 회복의 장단점은요?
3. 난소를 보존할 수 있나요?

10장. 수술 후 최종 병리와 추가치료

30초 요약

- **고위험 인자**(림프절 전이, 절제면 양성, 자궁주위조직 침범) 중 하나라도 있으면 **수술 후 항암방사선**(± 질 근접치료)을 권합니다.
- **중간위험 인자**(큰 종양, 깊은 기질 침윤, LVSI)가 겹치면 **수술 후 방사선**(± 항암)을 고려합니다.
- 위험 인자가 없으면 추적관찰로 넘어갑니다.

- 수술 전 예상 병기와 수술 후 병기가 다를 수 있습니다. 더 많은 조직 정보가 생긴 결과입니다.

- 수술 후 요실금·방광 기능 저하, 림프부종, 질 건조는 치료할 수 있는 부작용입니다. 숨기지 말고 알려 주세요.
- 난소를 보존했어도 방사선이 추가되면 난소 기능 보호를 다시 상의할 수 있습니다.

최종 병리 기록: 림프절 _/_ · 절제면 _ · **자궁주위조직** _ · 종양 크기 _ · **기질 침윤** _
 · LVSI _____ → 추가치료 ☐없음 ☐방사선 ☐항암방사선

11장. 국소진행성: 항암방사선 + 근접치료

30초 요약

- IIB~IVA(그리고 선택된 IB3~IIA2)는 **외부방사선 + 동시 항암** → **근접치료**가 근치 치료의 핵심입니다.
- 외부방사선은 보통 **주 5회 × 5~6주**, 근접치료는 외부방사선 **마지막 주 또는 직후**에 시작합니다.
- **전체 치료를 7~8주 안에 마치는 것이 이상적**입니다. 임의로 쉬지 말고, 쉬어야 할 일이 생기면 치료팀과 먼저 상의하세요.

🕒 **7~8주 원칙 상자** 1~5(6)주: 외부방사선 매일(평일) + 주 1회 항암 → 마지막 주 또는 직후: 근접치료 3~5회(약 2주) → **총 7~8주 내 완료** 근접치료 장비가 없는 병원이라면 **치료 시작 전에** 연계 병원과 근접치료 날짜를 확보하세요.

함께 쓰는 약

- **동시 항암:** 주로 **시스플라틴 주 1회**. 방사선 효과를 높이는 역할(방사선감작제)입니다. 신장 기능이 나쁘면 카보플라틴으로 바꿀 수 있습니다.
- 귀울림·청력 변화, 소변량 감소, 손발 저림은 다음 투약 전에 알려 주세요.
- **최근 선택지(모든 환자 대상 아님, 국내 허가·급여 확인 필요)**
- 병기에 따라 항암방사선에 **면역치료**(대표 예: 펌브롤리주맙)를 함께 쓰는 전략

- 항암방사선 전에 짧은 **유도항암**(카보플라틴 + 파클리탁셀)을 하는 전략
- 대동맥주위 림프절 전이가 있거나 의심되면 방사선 범위를 복부까지 넓힙니다.

치료 중 흔한 부작용

피로, 설사·복통, 빈뇨·배뇨통, 메스꺼움, 피부 자극, 혈구 감소. 대부분 치료 중 조절할 수 있습니다. **설사로 물을 유지하지 못하거나 38°C 이상 발열**이 있으면 바로 연락합니다.

주차별 치료 캘린더 (일반적 예시, 병원마다 다름)

주	치료	흔한 변화	내가 할 일	보호자 동행
0주	모의치료(CT·피부 표시), 채혈	—	통원 교통·직장 일정 확정	권장
1주	외부방사선 매일 + 항암 1회	피로 시작	수분 하루 1.5~2L(제한 없을 때)	항암일 권장
2주	// + 항암 2회	뭉은 변, 빈뇨	설사 기록, 지사제 사용법 확인	
3주	// + 항암 3회	피로 ↑, 식욕 ↓	단백질 보충, 짧은 걷기	
4주	// + 항암 4회	회음부 피부 자극	미지근한 물 세정, 면 속옷	
5주	// + 항암 5회	혈구 감소 가능	발열 시 즉시 연락	항암일 권장
6주	외부방사선 마무리(± 항암) · 근접치료 시작	피로 정점	근접치료 당일 준비	근접치료일 필수

주	치료	흔한 변화	내가 할 일	보호자 동행
7- 8주	근접치료 마무리	점차 회복	질 확장기 교육 일정 확인	근접치료일 필수

치료가 끝난 뒤 2~4주 동안은 증상이 조금 더 이어지다 좋아지는 경우가 많습니다.

치료 일정 기록: 외부방사선 시작일 __ · 동시항암 약/요일 _ · 근접치료 병원·횟수 ·
목표 종료일 · 면역치료/유도항암 해당 ____

오늘 물어볼 질문

1. 근접치료는 언제, 어디서, 몇 회 하나요? 전체 종료 목표일은요?
2. 저는 면역치료 병용이나 유도항암 대상인가요?
3. 치료 중 어떤 증상이면 밤에도 연락해야 하나요?

12장. 근접치료 — 빼면 안 되는 이유와 하루 안내

30초 요약

- 근접치료는 방사선원을 자궁경부 종양 **바로 옆**에 두어, 주변 장기를 덜 다치게 하면서 종양에 높은 선량을 주는 치료입니다.
- 외부방사선만으로는 이 선량을 줄 수 없어 **다른 치료로 대체할 수 없습니다.**
- 통증과 불편은 **마취·진정과 진통제로 조절**합니다. 불편하면 말하면 조절할 수 있습니다.

근접치료 하루 흐름 (일반적 예시)

1. 준비: 금식 지시 확인, 편한 옷, 보호자 동행, 귀가 교통편.

2. **기구 삽입**: 마취·진정 상태에서 자궁과 질에 가는 관(탠덤)과 링(또는 오보이드)을 넣습니다. 종양이 크면 바늘 모양 관을 더하는 **조직 내 근접치료**를 하기도 합니다.
3. **영상 촬영**: MRI 또는 CT로 기구 위치와 종양을 확인하고 그날의 치료 계획을 만듭니다(영상유도 근접치료).
4. **조사**: 기계에서 방사선원이 관을 통해 들어갔다 나옵니다. 조사 자체는 보통 10분 안팎입니다. 몸에 방사선이 남지 않습니다(고선량을 방식 기준).
5. **기구 제거 후 귀가** 또는 병원에 따라 1~2일 입원해 여러 번 조사.

끝난 뒤

- 소량 출혈·분비물, 배뇨 시 따가움이 며칠 있을 수 있습니다. 많은 출혈·발열은 연락합니다.
- **질 확장기**: 보통 방사선 종료 2~4주 뒤부터 병원 안내에 따라 시작합니다. 질이 좁아지고 붙는 것을 막아, 성생활 여부와 관계없이 **추적 골반 진찰을 가능하게** 합니다.
- 수분 기반 질 보습제를 함께 쓰면 도움이 됩니다.

오늘 물어볼 질문

1. 근접치료는 몇 회이고, 입원이 필요한가요?
2. 마취나 진정은 어떻게 하나요?
3. 질 확장기는 언제부터, 어떻게 쓰나요?

13장. 재발·전이로 진단받았다면: 바이오마커와 전신치료

30초 요약

- 원격전이(IVB)나 재발에서는 **바이오마커 검사**가 치료 선택의 출발점입니다. 특히 **PD-L1**(면역치료가 잘 들을지 보는 표지)이 1차 치료 선택에 중요합니다.
- 1차 치료는 **백금 항암 + 파클리탁셀**을 바탕으로, 조건에 따라 **면역치료**나 **혈관신생억제제(베바시주맙)**를 더합니다.
- 출혈·통증 같은 증상에는 방사선 등 국소치료를, 처음부터 **완화의료**를 함께 받을 수 있습니다.

바이오마커 검사(모든 재발·전이에서 권장)

검사	쉬운 뜻	왜 보나
PD-L1(CPS)	면역치료 반응 가능성 표지	1차 면역치료 병용 여부
HER2	특정 단백질 과발현	일부 표적치료·임상시험
MMR/MSI	DNA 오류 수선 기능	면역치료 대상 판단
TMB	종양 돌연변이 양	일부 면역치료 기준
RET 융합	드문 유전자 변화	표적치료 가능성
NTRK 융합	드문 유전자 변화(주로 자궁경부 육종)	표적치료 가능성

- 가능하면 조직으로 검사하고, 어렵다면 혈액으로 검사하기도 합니다. 진단 초기에 미리 검사하는 병원도, 재발 때 하는 병원도 있습니다.
- 바이오마커는 "많이 할수록 좋은 것"이 아닙니다. 치료 선택에 쓰일 검사를 시점에 맞게, 국내 허가·급여와 함께 확인합니다.

치료 단계 (범주, 국내 허가·급여 확인 필요)

1차 — PD-L1 양성: 백금 + 파클리탁셀 + 면역치료(대표 예: 펌브롤리주맙) ± 베바시주맙 ↳ 그 외: 백금 + 파클리탁셀 + 베바시주맙(± 다른 면역치료 조합)
2차 — PD-L1 양성·MSI-H/dMMR·TMB-H: 면역치료 ↳ 그 외: 항체-약물접합체(ADC, 대표 예: 티소투맙 베도틴) 등

골반 안에만 재발했다면

- 이전에 방사선을 받지 않았고 절제가 가능하면 **수술 후 방사선 + 항암**을 고려합니다.
- 이미 방사선을 받았다면 위치에 따라 **골반 내장 적출술**(방광·직장 등을 함께 떼고 재건) 같은 큰 수술, 재방사선, 전신치료 등을 경험 많은 센터에서 상의합니다.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.
- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서 확인합니다.
- 완화의료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서**: 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).
- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 둡니다.

증상별 대처표

증상	할 수 있는 것	바로 연락
질 출혈	지혈 처치, 방사선, 혈관 색전술	많은 출혈·어지럼
골반·허리 통증	진통제 단계 조절, 신경차단, 완화 방사선	새로 생긴 다리 힘 빠짐
다리 부종	압박·거상, 혈전 확인	한쪽만 갑자기, 흉통 동반
수신증(신장 부음)	요관 스텐트, 신루관(콩팥에 관)	소변 금감, 발열
피로·식욕부진	영양 상담, 빈혈 교정, 활동 조절	물도 못 마심

바이오마커 기록: PD-L1 CPS _ (**검사법** _) · HER2 _ · **MMR/MSI** _ · TMB _ · **RET/NTRK** _ 이전 골반 방사선 ☐없음 ☐있음

오늘 물어볼 질문

1. 제 치료 목표는 무엇이고, 1차 치료로 무엇을 권하시나요?
2. 바이오마커 검사는 어떤 것을 했고, 결과는 무엇인가요?
3. 제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?

14장. 신경내분비암(소세포암)이라면

30초 요약: 자궁경부 신경내분비암은 드물고 빨리 자랄 수 있어 **일반 자궁경부암과 다른 경로를** 따릅니다. 병리 재확인과 경험 많은 센터의 다학제 진료, 임상시험 참여를 적극 고려합니다.

- 4cm 이하 초기: 근치 자궁절제 후 항암 또는 항암방사선, 또는 처음부터 항암방사선 + 근접치료.
- 4cm 초과·국소진행: 항암방사선 + 근접치료를 우선하며 이후 항암을 더할 수 있습니다.
- 재발·전이: 소세포폐암과 비슷한 항암(백금 + 에토포시드) 범주, 이후 면역치료 등.
- 가임력 보존 수술과 난소전위술은 일반적으로 권하지 않습니다.

2차 소견과 병원 선택

30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때
- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 자궁경부암 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요? 아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)
- ☐ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- ☐ 영상 CD + 판독지
- ☐ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- ☐ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.
- 임상시험에 참여해도 언제든지 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
 2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?
 3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?
-

PART 3. 30일 실행 로드맵

아래는 "대부분의 환자가 이 순서로 겪는" 흐름입니다. 내 일정이 더 빠르거나 느려도 괜찮습니다. 칸을 채우며 쓰세요.

Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 병리보고서 사본(침윤암·조직형) ☐ 부인종양 전문의 예약 ☐ 가임력 희망 정리
- ☐ 응급 연락처 저장(W1) ☐ 산정특례 문의 ☐ 마음 온도계 기록

Day 4-7 · 검사받기

- ☐ 골반 MRI ☐ PET/CT 또는 CT ☐ 혈액·신장 기능 ☐ (권유 시) HIV 검사
- ☐ 생식식학과 상담(해당 시) ☐ 보험 서류 목록 확인 ☐ 회사에 근무 조정 상의 시작

Day 8-14 · 결정하기

- ☐ 병기·림프절 결과 설명 듣기 ☐ 수술 vs 항암방사선 경로 결정
- ☐ 필요하면 2차 소견(슬라이드·CD 준비) ☐ 난자/배아 동결·난소전위 일정
- ☐ 근접치료 병원·일정 확보(항암방사선 경로)

Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 수술 경로: 수술 전 검사, 입원 준비, 간병 계획
- ☐ 항암방사선 경로: 모의치료, 통원 교통·주차, 항암 전 채혈 일정, 7~8주 달력 만들기
- ☐ 전이 경로: 바이오마커 결과 확인, 1차 치료 시작, 완화의료팀 연결

Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 첫 치료 시작 ☐ 증상 일지 시작(W3) ☐ 치료 중 응급 기준 재확인
 - ☐ 보험 청구 1차 접수 ☐ 가족·직장에 일정 공유 ☐ 나를 위한 30분 확보
-

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

배뇨·장 기능 변화

30초 요약: 근치 수술 뒤에는 소변 감각이 일시적으로 둔해지고, 골반 방사선 중에는 설사·빈뇨가 흔합니다. 대부분 조절할 수 있습니다. **소변이 나오지 않거나, 심한 설사·출혈, 새 옆구리 통증**은 바로 연락합니다.

- 근치 자궁절제 후: 잔뇨 측정, 필요 시 자가도뇨 교육. 시간을 정해 소변 보기.
- 방사선 중 설사: 기름진 음식·유제품·카페인을 줄이고, 처방받은 지사제 사용법을 미리 확인.
- 치료 후 수개월~수년 뒤 드물게 혈뇨·혈변, 요관 협착이 생길 수 있어 추적이 필요합니다.
- **골반저 재활(케겔 운동, 물리치료)**은 배뇨·배변·성기능 회복을 돕습니다. 재활의학과·골반저 물리치료를 요청하세요.

증상 기록: 하루 소변 _회·야간뇨 _ · 설사 _회·출혈 ☐없음 ☐있음 · 통증 _/10

성 건강·폐경·림프부종

30초 요약: 질 건조·협착, 성교통, 조기폐경 증상, 다리 림프부종은 **참아야** 하는 부작용이 아니라 **치료할 수 있는 문제**입니다.

- **질 건조·협착:** 수분 기반 질 보습제(매일 사용 가능), 질 확장기, 필요 시 질 에스트로겐(개인별 상담).
- **조기폐경:** 난소를 떼거나 방사선을 받으면 안면홍조·불면·기분 변화·질 위축이 올 수 있습니다. **폐경호르몬요법(MHT)**이 가능한지 개인별로 상담합니다 (자궁경부암 자체는 대개 호르몬과 무관하지만 조직형·병력에 따라 판단).

- **뼈 건강:** 골반 방사선은 골반 골절 위험을 높일 수 있고, 조기폐경은 골밀도를 낮춥니다. 골밀도 검사를 상의하세요.
- **림프부종:** 다리·외음부가 묵직하고 붓는 느낌을 기록하세요. 피부 보호, 적정 체중, 운동, 압박 요법이 도움이 됩니다. 붓는 다리에 **열감·발적·발열**이 생기면 봉와직염 가능성이 있어 빨리 진료받습니다.
- **성생활 재개:** 시점은 치료 종류에 따라 다릅니다. 성의학·성재활 상담을 이용할 수 있습니다.

파트너와 이야기할 때: "몸이 변해서 천천히 다시 시작하고 싶어. 아프면 멈춰 줘." 신체 변화는 혼자 감당할 일이 아닙니다.

추적: 재발 확인 + 후유증 관리

30초 요약: 치료 후 추적은 **진찰(골반 진찰)과 증상 확인**이 중심이고, 영상은 병기·치료에 따라 정해진 시점이나 증상이 있을 때 합니다.

시기	진찰 간격(일반적 예시, 위험도에 따라 다름)
치료 후 1~2년	3~6개월마다
3~5년	6~12개월마다
5년 이후	1년마다(개인 위험도에 따라 조정)

국내 자료로는 근치 수술을 받은 초기 환자의 5~20%가 재발하며, 그중 절반은 1년 안, 대부분은 3년 안에 생깁니다. 재발해도 일찍 찾으면 완치를 기대할 수 있는 경우가 있어, 처음 2~3년의 추적 일정이 특히 중요합니다.

- IB3·2·3·4A기이거나 방사선(항암방사선)을 받았다면 치료 종료 **3~6개월 뒤 PET/CT** 등을 할 수 있습니다.

- 가임력 보존 수술 후에는 골반 MRI를 6개월 뒤, 이후 2~3년간 매년 하는 방식이 제시됩니다.
- 세포검사(Pap)는 새 전암병변을 찾는 데 도움이 되지만 재발 발견에는 한계가 있습니다.
- **다음 진료까지 기다리지 말고 알릴 증상:** 새 질 출혈·분비물, 혈뇨·혈변, 골반·허리·다리 통증, 다리·배 부종, 지속되는 기침·숨참, 식욕 저하·체중 감소.

나의 추적 계획: 다음 외래 _ · 영상 _ · 세포/HPV 검사 _ · 재발·림프부종 _ · 폐경·골 건강 _____

치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
메스꺼움·구토	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰 (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커	하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음
피로	짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청	숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능
입안 혈음	부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금·베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기	통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반
변비	수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께	3일 이상 변이 없고 복통·구토, 배가 부풀

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
설사	수분· 전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사
불면	일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용(지시대로)	2주 이상 계속, 불안·우울 동반
탈모	순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단	— (대개 치료 후 다시 자람)
피부 발진·건조	순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단	물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막(입·눈) 침범
손발 저림	찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의	단추·젓가락·걷기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기
식욕 저하·체중 감소	먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충 음료	한 달 5% 이상 체중 감소, 평소의 절반 이하로 1주 이상

열이 나면: 항암 중 38℃ 이상(병원 기준에 따라 37.8℃ 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

날짜 점수(0~10) 가장 힘든 것(☐ 걱정 ☐ 잠 ☐ 통증 ☐ 돈 ☐ 가족 ☐ 일 ☐ 기타)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 견디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면 국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

불안이 물려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.

3. **내 몫 나누기**: 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기**: 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

"내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 듣고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

보호자에게

보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당**: 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당**: 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구**: 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.
- **결정은 환자가**: 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

피하면 좋은 말과 바뀌 쓸 말

피하면 좋은 말	바뀌 쓸 말
"긍정적으로 생각해야 나아"	"힘든 마음 그대로 말해도 돼"
"왜 검진을 안 받았어"	"지금부터 같이 챙기자"
"○○ 먹으면 낫는데"	"새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자"
"너보다 더 힘든 사람도 있어"	"네가 힘든 건 힘든 거야"

아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로**: "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 곳이 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 윗은 병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법, 2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원 사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

직장과 일상

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

먹는 것과 움직이는 것

식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.
- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋은 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.

- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
 - 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
 - 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
 - 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ **1544-9030**을 이용하세요.
-

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

항목	내용(2026.10 기준, 확인 필요)
대상	암으로 확진된 환자(자궁경부암 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인
혜택	건강보험 급여 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름
기간	적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사
신청 시한	확진일로부터 30일 이내 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용
방법	진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능

확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

제도	핵심	문의
본인부담상한제	1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외)	국민건강보험공단 1577-1000
재난적 의료비 지원	소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)	공단 지사·병원 사회사업팀
국가 암환자 의료비 지원	의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원	주소지 보건소
병원 사회사업팀 (의료사회복지사)	후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움	진료 병원 사회사업팀

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

3. 보험 청구 서류 체크리스트

민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

서류	어디서	메모
병리보고서(조직검사 결과지)	진단 병원 의무기록팀	바이오마커 결과 포함 여부
병리 슬라이드·파라핀 블록 대여	진단 병원 병리과	다른 병원 재판독·추가검사에 필요. 반납 기한 확인

서류	어디서	메모
영상 CD + 판독지	진단 병원 영상의학과· 의무기록팀	CT·MRI·PET 모두
혈액검사 결과	의무기록팀	최근 것
진료의뢰서(소견서)	담당 의사	상급종합병원 외래는 의뢰서가 있어야 건강보험 적용

자궁경부암 참고: 진단서 질병코드는 침윤암이면 C53, 상피내암이면 D06
계열입니다. 민간보험에서는 상피내암(D06)이 "유사암"으로 분류되어
진단비가 다를 수 있으니 약관을 확인하세요.

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다.

1. 제 진단은 전암병변인가요, 침윤성 자궁경부암인가요?
2. 정확한 조직형과 FIGO 병기는 무엇인가요?
3. 골반 MRI·PET/CT나 림프절 평가가 더 필요한가요?
4. 제 경우 수술과 항암방사선 중 어느 경로가 적합한가요?
5. 수술한다면 수술 방법과 수술 후 추가치료 가능성은요?
6. 항암방사선이라면 근접치료는 언제, 어디서, 몇 회이고 전체 종료일은요?
7. 임신을 원한다면 자궁·가임력 보존이 가능한가요?
8. 재발·전이라면 PD-L1 등 바이오마커 검사가 필요한가요?
9. 치료 중 바로 연락해야 할 증상은 무엇인가요?
10. 치료 후 림프부종·성 건강·폐경·배뇨 문제는 어디서 관리하나요?

내 자궁경부암 한 장 요약

항목	내 기록
진단	전암 / 미세침윤 / 침윤성 암
조직형	편평상피 / 선암 / 선편평 / 신경내분비 / 기타 _____
FIGO 병기	Stage _____ (✅ 확정 / ⌚ 대기)
종양 크기	_____ cm
림프절	골반 _ · 대동맥주위 _

항목	내 기록
LVSI / 절제면	LVSI _ · 절제면 _
주요 영상	MRI _ · PET/CT _
가임력 희망	없음 / 있음 / 상담 필요
첫 치료	수술(종류 _____) / 항암방사선 + 근접치료 / 전신치료 / 기타
바이오마커	PD-L1 CPS _ · MSI/MMR _ · 기타 _____
산정특례	☐ 신청 ☐ 등록 완료 (날짜 _____)

오늘 꼭 물을 3가지: ① 제 FIGO 병기와 림프절 상태는? ② 첫 치료는 수술인가요, 항암방사선인가요? ③ 가임력 보존이나 근접치료 준비를 지금 시작해야 하나요?

같은 진단, 다른 30일 — 세 사람의 이야기 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다. 실제 인물과 무관하며, 치료 결과를 예측하지 않습니다.

31세 지은 씨 — IB1, 임신 희망 "자궁을 지킬 수 있느냐"가 가장 무서운 질문이었다. 첫 진료에서 "임신을 원한다"고 먼저 말했더니 그날 생식외과 의뢰서가 나왔다. MRI에서 종양이 2cm 미만, LVSI가 없다는 걸 확인하고, 가임력 보존 수술 경험이 많은 병원에서 2차 소견을 받았다. 난자 동결은 수술 전 2주 안에 끝났다. 그녀가 남긴 말: "치료가 늦어질까 봐 말을 못 할 뻔했는데, 말한 덕분에 일정이 오히려 정리됐어요."

46세 미선 씨 — IIB, 항암방사선 + 근접치료 매일 통원이 가장 큰 벽이었다. 회사에 "8주간 오전 반차"를 먼저 제안했고, 남편과 근접치료 날만큼은 함께 가기로 정했다. 근접치료 장비가 없는 집 근처 병원 대신, 처음부터 근접치료까지 가능한 병원을 골랐다. 3주차 설사가 힘들었지만 지사제 쓰는 법을 미리 배워 버텼다. "7~8주라는 숫자를 알고 나니, 오늘이 며칠째인지 세는 게 힘이 됐어요."

63세 정숙 씨 — IVB, 보호자 딸과 함께 "남은 선택이 있느냐"고 물었을 때, 담당 교수는 PD-L1 결과부터 확인하자고 했다. 딸은 진료 기록지를 맡았고, 완화의료팀이 통증과 잠을 먼저 잡아 주었다. 정숙 씨는 사전연명의료의향서를 "아직은 아니다"라며 미뤘고, 그 결정도 존중받았다. "치료 목표를 처음 들었을 때 오히려 마음이 편해졌어요. 무엇을 위해 치료하는지 알게 됐으니까."

용어사전

용어	쉬운 뜻
침윤암	상피 아래 조직까지 뚫고 들어간 암. 전암병변과 구분
CIN / HSIL	자궁경부 상피내종양(전암병변). 숫자가 클수록 진행
AIS	상피내선암. 선암의 전암병변
원추절제(LEEP·냉원추절제)	자궁경부를 원뿔 모양으로 떼는 시술
근치적 자궁경부절제	자궁경부만 넓게 떼고 자궁을 남기는 가임력 보존 수술
A형·B형·C1형 자궁절제	수술 범위에 따른 자궁절제 분류. A형은 단순, C1형은 근치
광범위 자궁절제술	'근치 자궁절제'를 국내 동의서·안내문에서 흔히 부르는 이름
강내 방사선치료	근접치료를 부르는 다른 이름
동시항암화학방사선치료	CCRT의 국내 정식 이름 — 이 책의 '항암방사선'
LVSI	림프혈관 침범. 암세포가 림프관·혈관 안에 보이는 것
절제면	떼어낸 조직의 가장자리. 암이 닿아 있으면 양성
자궁주위조직	자궁경부 옆 지지조직(parametrium)
수신증	요관이 눌러 신장이 붓는 상태

용어	쉬운 뜻
FIGO 병기	국제부인산과연맹의 자궁경부암 병기 체계(2018)
감시림프절	암이 처음 퍼지는 림프절
CCRT(동시 항암방사선)	방사선과 항암을 같은 기간에 함께 하는 치료
외부방사선(EBRT)	몸 밖 기계에서 쏘는 방사선
근접치료	방사선원을 종양 가까이 넣어 하는 방사선치료
유도항암	주 치료 전에 먼저 하는 항암
난소전위술	방사선 범위 밖으로 난소를 옮기는 수술
PD-L1(CPS)	면역치료 반응 가능성을 보는 표지와 그 점수
ADC(항체-약물접합체)	항체에 항암제를 붙여 암세포에 전달하는 약
골반 내장 적출술	골반 재발 시 여러 장기를 함께 떼는 큰 수술
질 확장기	방사선 후 질 협착을 막는 기구
폐경호르몬요법(MHT)	폐경 증상을 줄이는 호르몬 치료

자주 묻는 질문 12

Q1. 자궁경부암은 성관계로 옮나요? 암 자체는 옮지 않습니다. 원인 바이러스인 HPV는 성접촉으로 전파되지만 매우 흔하며, 검사로 누가 언제 옮겼는지 알 수 없습니다.

Q2. 원추절제로 끝낼 수 있나요? 아주 초기(IA1 등)이고 절제면이 깨끗하면 원추절제로 치료가 끝나는 경우가 있습니다.

Q3. 자궁을 떼면 여성성이 사라지나요? 자궁을 떼도 성생활은 가능하며, 난소를 보존하면 호르몬도 유지됩니다. 몸의 변화에 대한 감정은 상담에서 다룰 수 있는 주제입니다.

Q4. 항암방사선 중 성관계를 해도 되나요? 치료 중에는 출혈·감염·통증 때문에 피하라고 안내하는 경우가 많습니다. 재개 시점은 치료 종료 후 의료진과 상의하세요.

Q5. 근접치료는 많이 아픈가요? 마취·진정과 진통제로 조절합니다. 불편이 크면 말하면 조정할 수 있습니다.

Q6. 치료 중 생리는 어떻게 되나요? 골반 방사선이나 난소 제거 후에는 생리가 멈추고 조기폐경이 올 수 있습니다.

Q7. 방사선치료를 받으면 몸에서 방사선이 나오나요? 외부방사선과 고선량을 근접치료는 몸에 방사선이 남지 않아 가족과 평소처럼 지내도 됩니다.

Q8. 딸에게 HPV 백신을 맞혀야 할까요? HPV 백신은 국가예방접종 대상 연령이 정해져 있습니다. 자녀 예방에 의미가 있으니 소아청소년과와 상의하세요. 성인 여성 가족은 만 20세 이상 2년마다 국가 자궁경부암 검진(세포검사) 대상입니다.

Q9. 치료 후 세포검사는 계속 하나요? 치료 종류에 따라 다르며, 새 전암병변을 찾는 데 도움이 됩니다. 담당의의 추적 계획을 따르세요.

Q10. 다리가 붓는데 림프부종인가요? 골반 림프절 수술·방사선 후 생길 수 있습니다. 한쪽만 갑자기 붓고 아프면 혈전일 수 있어 바로 연락하세요.

Q11. 폐경호르몬요법을 써도 되나요? 자궁경부암(특히 편평상피암)은 대개 호르몬과 무관해 개인별로 쓸 수 있는 경우가 많지만, 조직형·병력에 따라 판단합니다.

Q12. 질 확장기는 꼭 써야 하나요? 방사선 후 질이 좁아지고 붙는 것을 막아, 성생활 여부와 관계없이 추적 진찰을 가능하게 합니다. 사용 시기와 방법을 교육받으세요.

진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

30초 요약: 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

진료 전날

- ☐ 질문 3개를 우선순위로 적기(워크북 W2)
- ☐ 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩
- ☐ 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

진료실에서

1. **첫 문장으로 가장 중요한 것부터:** "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."
2. 어려운 말이 나오면: "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"
3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 **먼저 의료진에게 양해를 구하세요.**
허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

검사 준비 카드

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
CT(조영)	몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)	조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성	촬영은 10~20분
MRI	금속 제거, 일부는 금식	심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능	30~60분
PET/CT	(FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내	당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유	주사 후 대기 포함 2~3시간
조직검사 (바늘)	금식 여부 확인	혈액을 묽게 하는 약(중단 여부는 의료진 지시), 알레르기	시술 후 관찰 수시간
내시경	금식, 대장은 장 정결제	혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약	진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지
뼈스캔	주사 후 물 많이 마시기	임신·수유	주사 후 2~4시간 대기

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

항목	기록
담당 교수 / 진료과	
평일 진료실·외래 간호사실 ☎	
야간·휴일 연락처 ☎	
가까운 응급실(치료 병원 우선)	
항암·방사선 치료실 ☎	
보호자 1 / 보호자 2 ☎	
국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시)	☎ 1577-8899
암생존자통합지지센터(지역암센터)	☎ 1577-9740
응급 119 · 정신건강 위기 109	

W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

항목	기록
날짜 / 진료과 / 의사	
오늘 들은 진단·병기	☒ /  / ?
오늘 결정된 것	
다음 검사·날짜	
다음 진료 날짜	
새로 받은 약	
꼭 지켜야 할 주의사항	
다음에 물어볼 것	

W3. 7일 증상 일지

날 짜	체온 (최고)	통증 0~10	식사(평소의 %)	배변· 배뇨	잠	기분 0~10	메모·연락 여부

W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐
				☐
				☐

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은
수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

주	날짜	한 일(✅) / 남은 일(⌚)
1주	Day 0-7)	
2주	Day 8-14)	
3주	Day 15-21)	
4주	Day 22-30)	

W6. 자궁경부암 전용: 7~8주 항암방사선 달력

주	월	화	수	목	금	메모(항암일·채혈·근접치료)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Cervical Cancer, Version 2.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 자궁경부암 정보(센터 페이지 최종수정 2024.08.28본 확인), 대한부인종양학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **참고문헌:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터, 자궁경부암 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.

- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.
-

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>